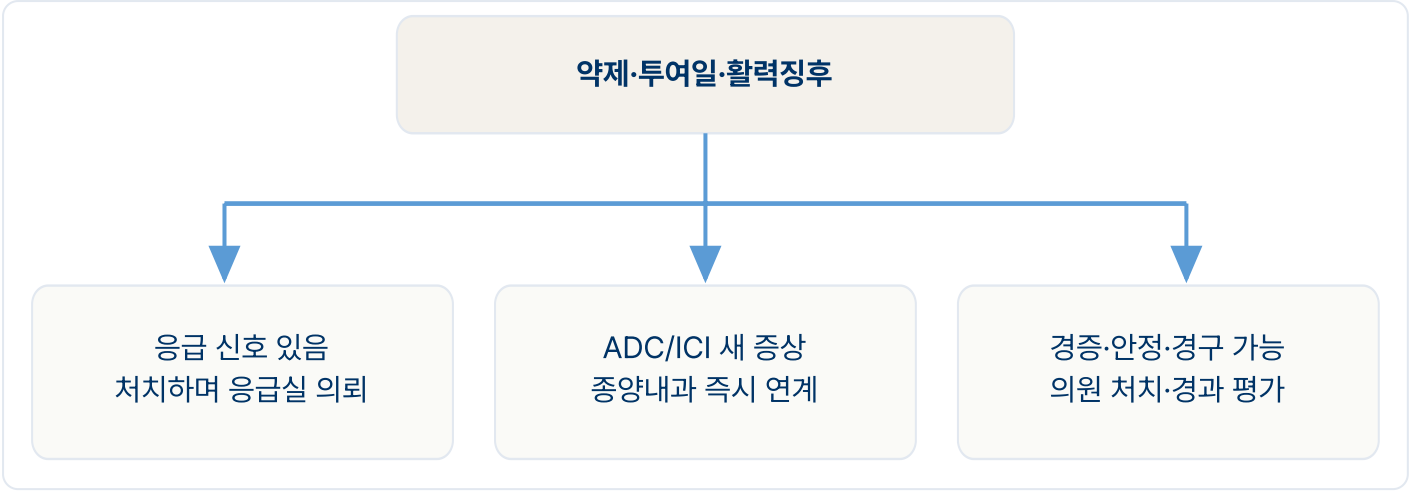
항암 환자 초진 응급 신호부터 분기

어떤 항암제인가 · 마지막 투여일 · 임상시험 여부



즉시 응급실 의뢰

체온 ≥38.3°C 또는 ≥38.0°C ≥1시간, 새 호흡곤란, 멈추지 않는 설사·혈변, 의식변화·심한 두통·국소신경증상, 흉통·저혈압·탈수·무뇨, 황달·간수치 급등은 즉시 연계합니다.

! 발열 + 항암 7~14일

세포독성 항암 후 nadir 감염은 수 시간 내 패혈증으로 진행할 수 있습니다. 체온·활력징후·마지막 항암일을 확인하고 가능하면 CBC/ANC를 봅니다. Nadir+지속 고열은 지체 없이 의뢰합니다.

경증·안정 환자

경구 섭취 가능한 경한 구역·구토, ICI를 점검한 경한 설사, 구내염·식욕저하, 경한 피부발진·소양감은 의원 증상 관리를 고려합니다. 수액은 보조이며 임상시험 참여자는 처방 전 연구팀에 연락합니다. 응급 처치는 연락 때문에 늦추지 않습니다.

감기·장염처럼 보이는 독성

ADC·ICI와 주요 종양학적 응급을 기억

ADC · 엔허투(T-DXd)

마른기침·호흡곤란·미열은 ILD 초기 신호입니다. 흔히 치료 6개월 이내 발생하며 강의 음성은 약 0.5%의 위험한 ILD를 강조했습니다. 산소포화도를 확인하고 새 호흡기 증상은 즉시 종양내과에 연결합니다. 항생제만 반복하지 않습니다.

ICI · 면역관련 이상반응(irAE)

키트루다·옵디보·리브타요·티쎈트릭·임핀지·바벤시오·여보이 등의 치료력을 묻습니다. 설사/대장염·폐렴·간염·갑상선/부신/뇌하수체 등 어느 장기에도 생기며 종료 후에도 가능합니다. 중등도 이상은 스테로이드가 필요할 수 있어 지사제·항생제만 반복하지 말고 담당팀에 즉시 연락합니다.

척수압박 · 고칼슘혈증

새로 악화된 등통증+하지 위약·감각저하·요실금/변실금은 척수압박을 생각하고 응급 의뢰합니다. 다음·다뇨·오심·혼돈·무기력과 고칼슘혈증은 생리식염수 치료를 시작하며 의뢰합니다.

그 밖의 종양학적 응급

얼굴·목 부종+경정맥 팽대·호흡곤란은 상대정맥증후군으로 자세를 올리고 의뢰합니다. 종양 치료 초기 고K·고인산·고요산·저Ca·신손상은 종양용해증후군, 조절 안 되는 출혈·새 호흡곤란/하지부종은 출혈·PE/DVT를 생각하고 의뢰합니다.

의원에서 가능한 증상 관리

안정 환자에서 처치하고 악화 신호를 재평가

돌발성 CINV

예방요법과 다른 기전 약제를 규칙 투여하고 수분·전해질을 교정합니다. 강의: olanzapine 5~10 mg 하루 1회 ×3일(음성 5 mg, 고령 2.5 mg), metoclopramide 10 mg 하루 3회 단기 3~5일, lorazepam 0.5~1 mg 필요시(예기성). Dexamethasone 4~8 mg 하루 1~2회는 슬라이드 지연성 구토 선택지입니다.

! 구토 의뢰 · 정재호 연자 Q&A

경구 수분/약 유지 불가, 탈수·소변 감소·전해질 이상, 토혈/커피색 구토·심한 복통, ≥24시간 금식, 의식저하·고령 노쇠, rescue 후 24~48시간 불응이면 의뢰합니다. Q&A는 olanzapine을 인정 비급여, 2.5 mg도 효과가 좋다고 설명했습니다. 장폐색·두개내압 상승·대사 이상을 감별합니다.

설사·구내염·피부

ICI 여부를 먼저 점검한 경한 설사는 loperamide·smectite와 수분 보충을 고려합니다. 구내염은 가글(Tantum)·국소관리, 가려움/경한 발진은 보습·국소 스테로이드·항히스타민을 소개했습니다. 손발증후군은 보습/유레아·압력 회피·물집 보존, 심하면 항암제 휴약/감량 연계입니다.

수액·포트·진료 조율

경구·경장 영양이 우선입니다. 생리식염수·하트만액, 포도당·아미노산 등은 보조로 사용합니다. Chemoport는 전용 Huber needle이 필요하며 익숙하지 않으면 말초 정맥로가 안전합니다. 안정적 장기생존자의 만성질환·예방 관리와 활성 치료의 독성/반응 평가는 연계합니다.